

Melanom — Handeln und Dringlichkeit

Screening-Stil · T2/T3 primär · SCOPE orthogonal

112 nur bei vitaler Begleitlage

T1 · Ausnahme

Im Melanom-Screening typischerweise **nicht** primär 112; Ausnahme nur bei vital bedrohlicher Begleitlage (z. B. akute schwere Blutung, Schock). Dann Notruf und Standard-Notfallmanagement; Melanom selbst ist primär onkologisch-dermatologisch zeitkritisch, nicht reanimationspflichtig.

Gleichtags bis zeitnah

Handlung: Therapie an der Läsion stoppen; **keine** destruktiven Maßnahmen; gleichtags Hausarzt/Dermatologie bzw. onkologisch-dermatologische Abklärung; schriftlich „Melanom-DDx / ABCDE-suspekt?“ und Befundbeschreibung mitgeben.

T2

(Bei Blutung/Ulzeration und systemischen Zeichen eher gleichtags.)

- Blutende oder ulzerierte unklare Hautläsion
- ABCDE-suspekte oder rasch wachsende pigmentierte Läsion
- B-Symptomatik plus multiple Hautknoten

Zeitnah

Handlung: Schriftliche Zuweisung Dermatologie/Hausarzt zur Exzisionsabklärung; Patient über Dringlichkeit und Rückkehrgründe informieren.

T3

- Neu aufgetretene subunguale Pigmentierung kombiniert mit Nagelwall-Pigmentierung (Verdacht auf Hutchinson-Zeichen)
- Ugly Duckling ohne akute Blutung

Behandeln + Sicherheitsnetz

T4

Handlung: Ohne suspekte Kriterien: MSK-Therapie fortsetzen; bei neu auffälliger Läsion im Verlauf sofort stoppen und zuweisen; auf gesetzliches Hautkrebs-Screening (in DE ab 35 Jahren alle 2 Jahre) hinweisen, ohne Screening zu ersetzen.

GRENZE DER EIGENEN ZUSTÄNDIGKEIT

Keine Melanom-Diagnose, keine Exzision, **keine** destruktiven Maßnahmen an suspekten Läsionen; endgültige DDx (seborrhische Keratose vs. Melanom) ist **ärztlich**.